

URGENCIAS FARINGOLARÍNGEAS

ABSCESOS CERVICALES

J. Prada Pendolero, K. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia.

A. Flemón /absceso periamigdalino

Introducción

Absceso/flemón entre amígdala y músculo constrictor superior. Complicación más frecuente de la amigdalitis bacteriana.

Típico adultos jóvenes.

Clínica: Fiebre+ odinofagia intensa + otalgia refleja + mal aliento+ voz engolada

Exploración: TRISMUS + abombamiento de pilar amigdalino y desplazamiento de úvula lado contralateral.



Diagnóstico

- Clínico+ punción positiva con salida de pus (absceso)

Tratamiento Urgencias

- AVISAR A ORL
- Antibiótico intravenoso + corticoides intravenoso (amoxicilina/clavulánico 1gr/8h o Clindamicina 300-600 mg/6h) + drenaje quirúrgico intraoral.

Nota

- Criterio de amigdalectomía de forma diferida.

B. Angina ludwig

Introducción

Polibacteriana. Infección suelo de la boca. En paciente con mala higiene oral o manipulación dental.

Clínica: Dolor cervical, voz engolada dificultad respiratoria

Exploración: Inflamación región submentoniana+ déficit de movilidad lingual+ protusión lingual

Diagnóstico

Clínica+ exploración+ TAC Cervical

Tratamiento Urgencias

Ingreso hospitalario.

Vigilancia estrecha. Antibiótico intravenoso: (amoxicilina/clavulánico 1 g/8h o clindamicina 600

mg/6 h o Meropenem 1g/8h) + corticoides intravenoso (mg/kg /24h)

Riesgo de complicación vía aérea

Avisar ORL

Nota

- Puede aparecer disnea brusca y necesidad de manejo de vía aérea urgente

Absceso retrofaríngeo

Introducción

Infección de los ganglios retrofaríngeos. Típico de niños.

Clínica: Fiebre +adenopatías+ odinofagia+ alteración en voz

Exploración: fluctuación pared faríngea posterior.



Diagnóstico

Clínica+ Rx lateral cervical

Tratamiento

- Antibiótico intravenoso: (amoxicilina-clavulánico 1g/8 h o Meropenem 1 gr/ 8h). Alérgicos: Clindamicina 600 mg/6 h o Metronidazol 500mg/8h + Gentamicina
- Puede requerir drenaje intra o extraoral
- Avisar ORL

Absceso parafaríngeo

Introducción

Absceso entre músculo constrictor superior y vaina vascular carotídea.

Riesgo de Síndrome Lemierre.

Exploración: MEG+ dolor cervical+ odinofagia



Diagnóstico

Clínico+ TAC cervical

Tratamiento

Antibiótico iv (Amoxicilina-clavulánico 1g/8 h o Meropenem 1 gr/ 8h). Alérgicos: Clindamicina 600 mg/6 h + Gentamicina

Puede requerir drenaje cervical

AVISAR ORL

Nota

- Control estrecho del paciente. Control hemodinámico. Riesgo elevado de mediastinitis y sepsis. Valorar criterios de UCI.

Bibliografía

- Page C, Biet A, Zaatar R, Strunski V. Parapharyngeal abscesses: diagnosis and treatment. Eur ArcOtorhinolaryngol 2008;265(6):681-6
- Plaza Mayor G, Martínez San-Millán JM, Martínez Vidal A. Is a conservative treatment of Deep neck space infections appropriate? Head and Neck 2001;23(2):126-33
- Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento de los abscesos profundos del cuello, México; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009